



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : صبيه محمد صديق اسماعيل

العنوان : 5 كفر السلمانيه وراق
العرب الوراق الجيزه

الحى / المدينة : اخرى

المحافظة : كفر الشيخ

تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

رقم البطاقة : 27509141500807 رقم التليفون : 01117388937

العمر(تاريخ الميلاد) : 14-09-1975 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام تصوير مقطعي للصدر والبطن والحوض بالصبغة

قسم العلاج :
الأورام

[11129]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني

الاسم : د/ندى حسن

الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :

الوظيفة :

الوظيفة :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة

رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

قسم :

نفقات :

ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: صبيح محمد صديق اسماعيل National ID: 27509141500807	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen and pelvis.

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

طلب علاج أول مرة / متكرر

المحافظة : كفر الشيخ

رقم البطاقة : 27509141500807

المهنة : ربه منزل

التوقيع: (-----)

التعليق على التشخيص : -----

تتعهد المستشفى، أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- /د----- /د----- /د!----- /د!

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

رئيس
المجلس الطبي المتخصص


 جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية
 صبحية
 محمد صديق اسماعيل راضي
 ه كفر السلمان به - وراق العرب
 الوراق - الجيزة

 ٢٧٥٠٩١٤١٥٠٠٨٠٧
 LP1035528

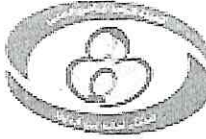
٢٠٢٦/٠١ ~ ٢٧٥٠٩١٤١٥٠٠٨٠٧
 ربة منزل

 أنثى مسلمة متزوجة
 سعيد عوض ابوالسعود حموده
 البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠١/٢٠

 ١



HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION



الهيئة العامة للتأمين الصحي
الإدارة المركزية للنظم المعلومات و التحول
الرقمي

رسوم الاستعلام 20 جنية

جهة الاصدار : فرع الجيزة

تاريخ الاصدار : 2026-8-18

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسي " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية

وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي

والبحث تبين أن

السيد (ة) صبحيه محمد صديق اسماعيل بطاقة رقم 27509141500807

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفحة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2026-8-18

الموظف المختص

احمد ياسر



إفادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 2054276

الخطاب ساري لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا في حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمي

Name : Sobhya Mohammed

Date : Saturday, August 13, 2026

**DIGITALIZED LOW DOSE SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY WITH
COMPLEMENTARY BREAST US EXAMINATION OF BOTH
BREASTS REVEALED:**

- ACR b: scattered fibro-glandular parenchyma.

Left breast:

- UOQ dense spiculated mass lesion seen corresponds by US to 3:00 heterogeneously hypoechoic non-parallel mass lesion; seen measuring 48x26mm about 5 cm distances from nipple and 8 mm deep to the overlying skin.
- Retro-areolar bilateral dilated ducts.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes.
- Left pathological axillary node is noted showing rounded shape, effaced fatty hilum measuring about 28x25mm.

Right breast:

- No suspicious irregular opacities or pathological microcalcification clusters.
- No solid or cystic lesions.
- Normal central ducts system.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes.
- Non-specific axillary lymph nodes showing preserved fatty hila.

Opinion:

- Left breast 3:00 malignant looking lesion with pathological ipsilateral axillary node (BIRADS 5); for histopathological assessment.
- Unremarkable right breast study.

*Best regards,
Dr. Shahenda Saber*

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



صباحية

محمد صديق اسماعيل راضي

ه كفر السلمان - وراق العرب

الوراق - الجيزة

٢٧٧٥/٠٩



٢٧٥٠٩١٤١٥٠٠٨٠٧

LP1035528

National ID - From
[[DOCT/PEID.F]]



٢٠٢٦/٠١ ٢٧٥.٩١٤١٥٠٠.٨٠٧

ربة منزل

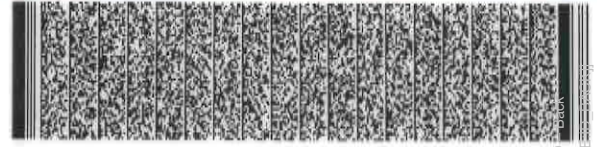


أنثى مصلمة متزوجة

سعيد عوض ابوالسعود حموده

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٣/٠١/٢٠

١



National ID
[ID007/P]

Name : Sobhya Mohammed

Date : Saturday, August 13, 2026

**DIGITALIZED LOW DOSE SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY WITH
COMPLEMENTARY BREAST US EXAMINATION OF BOTH
BREASTS REVEALED:**

- ACR b: scattered fibro-glandular parenchyma.

Left breast:

- UOQ dense spiculated mass lesion; seen corresponds by US to 3:00 heterogeneously hypoechoic non-parallel mass lesion; seen measuring 48x26mm about 5 cm distances from nipple and 8 mm deep to the overlying skin.
- Retro-areolar bilateral dilated ducts.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes.
- Left pathological axillary node is noted showing rounded shape, effaced fatty hilum measuring about 28x25mm.

Right breast:

- No suspicious irregular opacities or pathological microcalcification clusters.
- No solid or cystic lesions.
- Normal central ducts system.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes.
- Non-specific axillary lymph nodes showing preserved fatty hila.

Opinion:

- Left breast 3:00 malignant looking lesion with pathological ipsilateral axillary node (BIRADS 5); for histopathological assessment.
- Unremarkable right breast study.

Best regards,
Dr. Shahenda Saber



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جورستاف روسي شتر انترناتال - مصر معمل الباثولوجي



Patient Name	صبيحه محمد صديق اسماعيل	Case No.	359980
Sex/Age	Female 50 Y	Patient No.	26156
Registered Date	23/8/2026 02:26:07 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	15/9/2026 03:32:18 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	17/9/2026 12:32:41 PM	Pathology No.	2680/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 20/08/2026, at 1:54 pm. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

-Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:

-Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
-ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Mixed Invasive duct and lobular carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Negative membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 20%.

Conclusion:

Left breast mass, Tru-cut biopsy:

-Mixed Invasive duct and lobular carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- Her2: Negative (score 0).

rice
Kee



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناتيونال - مصر مستشفى البترول وجي



Patient Name	صبيحة محمد صديق الساعاتي	Case No.	359980
Sex/Age	Female 50 Y	Patient No.	26156
Registered Date	23/8/2026 02:26:07 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	15/9/2026 03:32:18 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	17/9/2026 12:32:41 PM	Pathology No.	2680/26

- Ki67%: 20%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 10%; 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

Name: Sobhya Mohammed

Date: Saturday, August 15, 2026

**DIGITALIZED LOW DOSE SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY WITH
COMPLEMENTARY BREAST US EXAMINATION OF BOTH
BREASTS REVEALED:**

- ACR b: scattered fibro-glandular parenchyma.

Left breast:

- UOQ dense spiculated mass lesion ^{2.5cm} seen corresponds by US to 3:00 heterogeneously hypochoic non-parallel mass lesion; seen measuring 48x26mm about 5 cm distances from nipple and 8 mm deep to the overlying skin.
- Retro-areolar bilateral dilated ducts.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes.
- Left pathological axillary node is noted showing rounded shape, effaced fatty hilum measuring about 28x25mm.

Right breast:

- No suspicious irregular opacities or pathological microcalcification clusters.
- No solid or cystic lesions.
- Normal central ducts system.
- Normal skin thickness and contour as well as nipple areola complexes.
- Non-specific axillary lymph nodes showing preserved fatty hila.

Opinion:

- Left breast 3:00 malignant looking lesion with pathological ipsilateral axillary node (BIRADS 5); for histopathological assessment.
- Unremarkable right breast study.

Best regards,
Dr. Shahenda Saber